

CuidaTrack — Modelo entidad-relación del núcleo transaccional

Documento de avance — sujeto a revisión del equipo y los profesores guía.

Qué cubre este modelo

El MER describe el **núcleo transaccional** de CuidaTrack: el registro de medicamentos, actividades de cuidado, citas médicas, evaluaciones de sobrecarga y alertas. No incluye las tablas de reportería/analítica, que se calculan a partir de estos datos y no necesitan persistirse como entidades propias.

Entidades

CUIDADOR — la persona que ejerce el cuidado informal. Es quien usa la plataforma: registra medicamentos, actividades, y responde las evaluaciones de sobrecarga.

PERSONA_MAYOR — el adulto mayor que recibe los cuidados. Es el sujeto central del sistema, aunque en este MVP no inicia sesión por su cuenta: toda la información sobre ella la ingresa su cuidador.

ASIGNACION_CUIDADO — tabla intermedia entre CUIDADOR y PERSONA_MAYOR. Existe porque esa relación es muchos-a-muchos en la práctica: una persona mayor puede tener más de un cuidador (turnos entre hermanos, por ejemplo), y un cuidador puede atender a más de una persona mayor. Guarda además el tipo de vínculo (relacion_parentesco) y desde cuándo rige.

MEDICAMENTO — catálogo de medicamentos. Existe como entidad separada porque el mismo medicamento se repite entre distintos tratamientos y distintas personas; evita duplicar su nombre y unidad de medida cada vez.

TRATAMIENTO — lo que fue indicado: qué medicamento, qué dosis, a qué hora, y por cuánto tiempo. Es el *plan*.

REGISTRO_MEDICAMENTO — lo que efectivamente ocurrió: cada vez que el cuidador administra el medicamento, queda un registro con la hora real y si estuvo dentro de la ventana esperada. Separar TRATAMIENTO (plan) de REGISTRO_MEDICAMENTO (ejecución) es lo que permite calcular adherencia — si estuvieran fundidos en una sola tabla, no habría forma de distinguir "lo que debía pasar" de "lo que pasó".

ACTIVIDAD_CUIDADO — registro de actividades de cuidado no farmacológicas: higiene, alimentación, movilidad, signos vitales.

CITA_MEDICA — citas médicas agendadas para la persona mayor.

EVALUACION_SOBRECARGA — resultado periódico de la escala de Zarit simplificada. Se asocia al **cuidador**, no a la persona mayor, porque mide el desgaste de quien cuida, no la condición de quien es cuidado.

ALERTA — alertas generadas por el sistema (omisión de dosis, inactividad prolongada, sobrecarga), originadas por la situación de una persona mayor y dirigidas a un cuidador.

Relaciones

Relación	Cardinalidad	Qué representa
gestiona	CUIDADOR 1 — N ASIGNACION_CUIDADO	Un cuidador puede tener varias asignaciones, una por cada persona mayor que atiende

1/10/26, 12:28	PERSONA_MAYOR 1 — N CUIDADOR	CuidaTrack — MER: entidades y relaciones Cada persona mayor que atiende.
recibe	PERSONA_MAYOR 1 — N ASIGNACION_CUIDADO	Una persona mayor puede tener más de un cuidador asignado. Junto con <i>gestiona</i> , esta relación resuelve el muchos-a-muchos real entre cuidador y persona mayor.
indica	PERSONA_MAYOR 1 — N TRATAMIENTO	Una persona mayor puede tener varios tratamientos, activos o históricos.
compone	MEDICAMENTO 1 — N TRATAMIENTO	Un mismo medicamento puede formar parte de varios tratamientos distintos.
genera	TRATAMIENTO 1 — N REGISTRO_MEDICAMENTO	Cada tratamiento acumula un registro por cada vez que se administró el medicamento.
registra	CUIDADOR 1 — N REGISTRO_MEDICAMENTO	Un cuidador puede haber hecho muchos registros de administración a lo largo del tiempo.
recibe	PERSONA_MAYOR 1 — N ACTIVIDAD_CUIDADO	Una persona mayor acumula muchas actividades de cuidado registradas.
registra	CUIDADOR 1 — N ACTIVIDAD_CUIDADO	Un cuidador puede registrar muchas actividades.
agenda	PERSONA_MAYOR 1 — N CITA_MEDICA	Una persona mayor puede tener varias citas médicas, pasadas y futuras.
responde	CUIDADOR 1 — N EVALUACION_SOBRECARGA	Un cuidador responde la evaluación de sobrecarga de forma periódica, acumulando un historial.
origina	PERSONA_MAYOR 1 — N ALERTA	La situación de una persona mayor (p. ej. una dosis omitida en su tratamiento) es la que dispara la alerta.
recibe	CUIDADOR 1 — N ALERTA	La alerta se notifica al cuidador responsable.

Decisiones de diseño a destacar

- **Plan vs. ejecución real** (TRATAMIENTO vs REGISTRO_MEDICAMENTO): es la base para medir adherencia — sin esta separación no se podría comparar lo indicado contra lo efectivamente hecho.
- **Tabla intermedia para el vínculo cuidador–persona mayor** (ASIGNACION_CUIDADO): modela correctamente que ese vínculo es muchos-a-muchos y no uno-a-uno.
- **La sobrecarga se mide sobre el cuidador, no sobre la persona mayor**: es un indicador de bienestar de quien cuida, consistente con uno de los objetivos del proyecto (autocuidado del cuidador).

